

GUIDE PRATIQUE DÉTAILLÉ

Prendre soin des femmes soumises à la violence : un programme d'études de l'OMS pour la formation des prestataires de soins de santé

WHO · English · 2019

Important: Il s'agit d'un guide de lecture non officiel détaillé et non d'une traduction officielle. Consultez la publication originale pour connaître les exigences complètes et le contexte.

Basé sur la publication originale

<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/330084/9789241517102-eng.pdf>

Contenu

1. Objectif et portée
2. Conseils clés
3. Comment utiliser ce guide
4. Principes centrés sur le survivant
5. Séquence de réponse pratique
6. Contrôles de sécurité et de qualité
7. Liste de contrôle des actions

01 Objectif et portée

- Un guide de formation destiné aux prestataires de soins de santé pour reconnaître la violence, offrir un soutien de première ligne, fournir des soins cliniques et connecter les femmes à des services sûrs.

02 Conseils clés

- Créez des conditions de consultation privée et ne posez jamais de questions sur les violences en présence d'un partenaire, d'un proche ou d'un interprète choisi par le partenaire.
- Utilisez l'assistance de première ligne : écoutez attentivement, renseignez-vous sur les besoins, validez, améliorez la sécurité et connectez-vous à l'assistance.
- Ne poser la question que lorsque cela est cliniquement pertinent et lorsqu'une voie de réponse sûre existe ; un interrogatoire de routine sans capacité de réponse peut causer du tort.
- Évaluez le danger immédiat, les menaces, les armes, le harcèlement criminel, l'étranglement, l'escalade de la violence et les menaces impliquant des enfants.
- Traitez les blessures et les conséquences sur la santé sans que la déclaration à la police soit une condition de soins.
- Documenter de manière objective, sécurisée et avec le consentement ; distinguer les observations des allégations et éviter les jugements.
- Expliquer la confidentialité et les limites de déclaration obligatoire avant la divulgation, y compris les règles spéciales affectant les enfants ou les personnes incapables.
- Pratiquez à travers des jeux de rôle supervisés, des exercices de réflexion et de référence ; les attitudes et les préjugés des prestataires affectent directement la qualité des soins.

03 Comment utiliser ce guide

- Ce guide transforme la publication source en une aide à la lecture pratique. Il est conçu pour les survivants, les sympathisants de confiance, le personnel de santé et des services sociaux et les responsables de programmes. Il ne remplace pas les services d'urgence, les soins médicaux, les conseils juridiques ou la publication source complète.
- Utilisez uniquement les pièces adaptées à la situation de la personne. Préservez son choix, son intimité et son rythme. Si une action suggérée pourrait exposer la navigation, les appels, les documents ou la localisation à une personne abusive, choisissez d'abord un appareil, un lieu ou une heure plus sûrs.

Principes centrés sur le survivant

- La sécurité passe avant tout. Demandez ce qui rendrait les heures ou les prochains jours plus sûrs et évitez les mesures susceptibles de provoquer des représailles. N'exigez jamais de divulgation afin d'offrir une aide de base.
- Respecter l'autonomie et le consentement éclairé. Expliquer les options réalistes, les avantages, les limites et les risques possibles ; c'est le survivant qui décide de la suite des événements, à moins qu'une obligation de sauvegarde légale immédiate ne s'applique.
- Protégez la confidentialité. Collectez le minimum d'informations, restreignez l'accès, convenez de méthodes de contact sûres et expliquez les limites avant que les informations ne soient partagées.
- Assurer un accès équitable. Tenez compte du handicap, de la langue, de l'âge, du statut migratoire, de la pauvreté, de l'isolement rural, de l'orientation sexuelle et d'autres obstacles sans stéréotypes.

Séquence de réponse pratique

- Commencez par la sécurité immédiate et les besoins de santé urgents. Demandez en privé, sans la présence de l'agresseur présumé, s'il est possible de parler en toute sécurité et si la personne a besoin de soins d'urgence.
- Écoutez sans interrogation. Validez ce qui s'est passé, évitez les reproches et n'exigez pas de récit chronologique ou de preuve. Enregistrez uniquement ce qui est nécessaire et utilisez les propres mots de la survivante.
- Proposer un petit nombre d'options vérifiées : soins médicaux, hébergement sûr, soutien psychosocial, informations juridiques, services de police ou de protection le cas échéant. Expliquez qu'accepter un service ne nécessite pas d'accepter tous les autres.
- Faites une référence chaleureuse lorsque le consentement est donné : confirmez que le service est ouvert, accessible et sûr ; expliquer à quoi s'attendre ; et évitez d'envoyer le survivant à plusieurs reprises entre les agences.
- Convenez d'un suivi et d'un moyen sûr de communiquer. Ne laissez pas de messages d'identification, n'envoyez pas de notifications révélatrices et ne stockez pas de fichiers sous des noms évidents si les appareils peuvent être surveillés.

06

Contrôles de sécurité et de qualité

- Ne confrontez pas l'agresseur présumé, n'intervenez pas dans une relation violente, ne promettez pas un résultat que vous ne pouvez pas contrôler ou ne faites pas pression sur un survivant pour qu'il parte immédiatement.
- N'utilisez pas de numéros de téléphone ou de références non vérifiés. Les services peuvent fermer, modifier les règles d'éligibilité ou partager des informations de manière dangereuse ; confirmer les détails avant la publication ou le renvoi.
- Les organisations doivent former le personnel, superviser les cas difficiles, créer des règles de documentation confidentielles, maintenir des cartes de référence à jour et offrir un soutien au personnel pour réduire l'épuisement professionnel et les pratiques néfastes.

07

Liste de contrôle des actions

- Est-il sécuritaire de parler, de lire ou de conserver ce document en ce moment ?
- Les blessures urgentes, les problèmes de grossesse, les soins en cas de violence sexuelle et le risque de suicide ont-ils été pris en compte ?
- La survivante a-t-elle choisi quelles informations peuvent être enregistrées ou partagées ?
- Les obstacles à l'interprétation, à l'accès des personnes handicapées, à la garde d'enfants, au transport et aux coûts sont-ils résolus ?
- Les références sont-elles vérifiées et existe-t-il un plan de suivi sécurisé ?
- A-t-on dit à la personne que la violence n'est pas de sa faute et qu'elle peut refuser n'importe quelle option ?